РОГИНОЛИТ

Натрия лактат

- В отличие от раствора бикарбоната, коррекция метаболического ацидоза с помощью натрия лактата происходит медленнее по мере его включения в обмен веществ, не возникает резких колебаний pH.
- Действие натрия лактата проявляется через 20-30 мин после введения.

Сорбитол

- Гипертонический раствор сорбитола оказывает выраженное стимулирующее действие на гладкую мускулатуру кишечника.
- В печени сорбитол вначале преобразуется во фруктозу, которая в дальнейшем преобразуется в глюкозу, а потом в гликоген.
- Гипертонический раствор сорбитола имеет высокое осмотическое давление и обладает выраженным свойством усиливать диурез.

Способ применения и дозирование

- **Рогинолит** вводят взрослым внутривенно капельно со скоростью 40-60 кап/мин.
- При значительной дегидратации внутривенные инфузии рогинолит необходимо вводить только капельно (не более 200 мл раствора в сутки).
- В случае необходимости допускается струйное введение препарата после проведения пробы путем капельного введения со скоростью 30 кап/мин. После введения 15 капель использование препарата прекращают, а через 3 мин в случае отсутствия реакции рогинолит можно вводить струйно.

При травматическом, ожоговом, послеоперационном и гемолитическом шоке	Взрослым вводят по 200-600 мл (3-10 мл/кг массы тела больного) одноразово и повторно по 200-400 мл
При заболеваниях печени	В дозировке 200 мл (3,5 мл/кг массы тела) капельно ежедневно или через день
При острой почечной недостаточности	Взрослым вводят в разовой дозе по 200-400 мл (2,5-6,5 мл/кг массы тела) капельно или струйно (повторно через 8-12 часов в дозировке 200 мл)
Для профилактики послеоперационного пареза кишечника	Взрослым вводят в разовой дозировке по 200-400 мл (2,5-5 мг/кг массы тела) капельно; повторные инфузии по 200 мл препарата каждые 12 часов на протяжении первых 2-3 суток после оперативного вмешательства
Для лечения послеоперационных парезов	В дозировке 200-400 мл (3,5-6,5 мл/кг массы тела) капельно через каждые 8 часов до нормализации моторики кишечника
При отеке мозга	Взрослым вначале струйно, а потом капельно (60-80 капель в минуту) вводят препарат в дозировке 5-10 мл/кг массы тела.

Побочные действия

- Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение или снижение артериального давления, тахикардия, одышка, акроцианоз.
- Неврологические расстройства: тремор, головная боль, головокружение, общая слабость.
- Желудочно-кишечные расстройства: боль в животе, тошнота.
- Общие расстройства: изменения в месте введения, включая боль и жжение.
- Могут возникать явления алкалоза

Противопоказания

- Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. рогинолит не применять при алкалозе, обезвоживании, а также в случаях, когда противопоказано вливание больших объемов жидкости (кровоизлияние в мозг, тромбоэмболия, сердечно-сосудистая декомпенсация, артериальная гипертензия III степени, терминальная почечная недостаточность, отек легких, анурия, олигурия.

Лекарственные взаимодействия

Не использовать в качестве растворителя-носителя для других лекарственных средств

Производитель: «СП ООО Samarkand England Eco-Medical» SEEM Innovation. Health of the nation.

200 мл

РОГИНОЛИТ

Плазмозамещающий кристаллоидный раствор, оказывающий полифункциональное действие

100 мл раствора содержит:

Сорбитол 6 г,
Натрия лактат 1.9 г,
Натрия хлорид 0,6 г,
Кальция хлорид 0,01 г,
Калия хлорид 0,03 г,
Магния хлорида гексагидрат 0,02 г.

Свойства раствора

- Осмолярность –– 1658 мОсмоль/л
- Энергетическая ценность – 240 ккал/л
- pH 6,0 – 7,6
- Ионный состав: 1 л препарата содержит Na+–272,20 ммоль, K+ – 4,02 ммоль, Ca++- 0,90 ммоль, Mg++ – 2,10 ммоль, Cl- – 112,69 ммоль, Lac- – 169,55 ммоль.

Показания к применению

Реаниматология

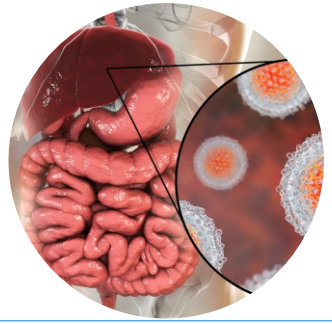
- Неотложные состояния
- Сепсис
- ОПН (острая почечная недостаточность) различной этиологии
- Перитонит
- Кишечная непроходимость

Неврология

- Повышенное внутричерепное давление при отеке мозга

Инфекционные болезни

- Гепатиты
- Холециститы
- Печеночная кома



При тяжелой политравме:

- Лечение травматического шока
- Профилактика и лечение острой почечной и печеночно-почечной недостаточности
- Энергообеспечение при парентеральном питании
- Лечение послеоперационного пареза кишечника и подготовка гастроинтестинального тракта для раннего энтерального питания.